IVAS · Cartão de Plantão

Para consultar à beira do leito; confira no protocolo do serviço

Perigo: referir [AIDPI]

Não bebe/mama · vomita tudo · convulsão < 72 h · letargia · TEC > 2 s · batimento de asa/gemência · estridor em repouso.

Crupe [SBP] [CPS]

Todos	Dexametasona dose única VO: 0,15–0,6 mg/kg (SBP); 0,6 mg/kg (CPS). IM se vômitos
Moderado, grave	Adrenalina 1:1.000 pura, nebulizar **0,5 mL/kg, máx. 5 mL**
Observar	2–4 h após o tratamento; efeito da adrenalina ~2 h
Internar	Toxemia, não bebe, estridor ou retração em repouso, sem resposta ou piora 2 h após adrenalina
UTI	Grave · qualquer hipoxemia (O_2 já) · falência iminente
Intubar	O mais experiente; cânula 0,5 mm menor

Não: nebulização com soro, ar úmido, antibiótico, β2.

Não é crupe [CPS] [SBP]

Epiglotite: tóxica, saliva, disfagia, sem tosse ladrante: colo, não agitar, sem abaixador, equipe de via aérea. **Traqueíte:** sem resposta à adrenalina: UTI, endoscopia, cefuroxima ou ceftriaxona IV.

Analgesia e febre [SBP-F] [AIDPI]

Paracetamol 10–15 mg/kg/dose 6/6 h (máx. 75 mg/kg/dia) · dipirona 10–12 mg/kg/dose 6/6 h · ibuprofeno 5–10 mg/kg/dose 8/8 h, > 6 meses, sem suspeita de dengue, máx. 200 mg/dose (AIDPI). Prescrever em mg; não alternar.

OMA [AIDPI] [AAP-O] [ABORL]

Abaulamento moderado/intenso ou otorreia nova (não otite externa). Analgesia já.

1ª linha MS	Amoxicilina **50 mg/kg/dia** 8/8 h (BD 12/12 h), **8 dias**; retorno 2 dias
Falha 2 dias	Amoxicilina 80 mg/kg/dia 12/12 h ou amox-clav; retorno 48 h
Alergia	Não imediata: cefuroxima 30 mg/kg/dia 12/12 h · imediata: claritromicina 15 mg/kg/dia
Sem VO/falha	Ceftriaxona 50 mg/kg/dia IM/IV: sem VO 1–3 dias; falha 3 dias
Mastoidite	1ª dose de antibiótico e referir já

Faringoamigdalite estreptocócica [AIDPI] [ABORL]

Benzatina IM	< 20 kg 600.000 UI · ≥ 20 kg 1.200.000 UI, dose única
Amoxicilina	50 mg/kg/dia 8/8 h, **10 dias**
Alergia	Claritromicina 15 mg/kg/dia 12/12 h (máx. 250 mg/dose) · eritromicina 40 mg/kg/dia, 10 dias

Abaulamento de palato ou membrana acinzentada: referir. Trismo, toxemia, estridor: abscesso?

Rinossinusite bacteriana [ABR]

Dupla piora após 5 dias ou quadro intenso sem melhora em 14. Amoxicilina **25–50 mg/kg/dia** 8/8 ou 12/12 h, 7–10 dias (90 se pneumococo resistente). Olho inchado, proptose, diplopia: TC com contraste e internar.

Não prescrever

Antibiótico no resfriado · RX de seios ou de pescoço de rotina · ASLO na faringite aguda · azitromicina na OMA · descongestionante de rotina · nebulização com soro no crupe.